Op. Dr. Murat Ayata
Kulak Burun Boğaz
Spécialiste en oto-rhino-laryngologie et chirurgie cervico-faciale

Cabinet médical privé Op. Dr. Murat Ayata
Karacaibrahim Mah. Dereüstü Sk., Merkez, Kırklareli, Turquie
Tél.: +90 288 502 50 20 · WhatsApp: +90 555 333 21 20
info@muratayata.com · www.muratayata.com

FORMULAIRE DE CONSENTEMENT ÉCLAIRÉ

Microchirurgie endolaryngée

Microchirurgie des cordes vocales / du larynx (microlaryngoscopie)

Chère patiente, cher patient, ce formulaire a été conçu pour vous expliquer, dans un **langage simple et clair**, ce que vous devez savoir sur l'intervention qui vous est proposée. Son objectif n'est pas de vous effrayer, mais de vous aider à prendre votre décision **librement et en connaissance de cause**.

Veuillez lire ce formulaire sans vous presser. Interrogez votre médecin sur tout ce que vous ne comprenez pas. Votre médecin vous expliquera également oralement les risques propres à votre situation. Donner ou non votre consentement est entièrement votre droit.

INFORMATIONS SUR LE PATIENT ET L'INTERVENTION

Nom et prénom : _____ Date de naissance : _____

N° de passeport / pièce d'identité : _____ N° de dossier / protocole : _____

Téléphone : _____ Date de l'information : _____

Date prévue de l'intervention : _____

Formulaire remis pour la première fois au patient (date / e-mail, WhatsApp, en main propre) : _____

Médecin réalisant l'intervention et délivrant l'information: **Op. Dr. Murat Ayata**

Établissement de santé où sera réalisée l'intervention : _____

Lésion / diagnostic préliminaire : _____

Côté : ☐ Corde vocale droite ☐ Corde vocale gauche ☐ Des deux côtés ☐ Autre zone du larynx _____

Technique prévue : ☐ Instruments froids ☐ Laser CO2 ☐ À décider par le chirurgien pendant l'intervention

Biopsie / examen anatomopathologique : ☐ Prévu(e) ☐ Si jugé(e) nécessaire ☐ Non prévu(e) _____

1 Votre état de santé et le but de l'intervention

Le larynx se situe à l'avant du cou. Il produit la voix, protège les voies respiratoires et ferme l'accès à la trachée lorsque vous avalez. Les cordes vocales sont deux fines structures situées à l'intérieur du larynx, qui vibrent pour produire le son.

Des lésions telles que des **nodules, polypes, kystes, un œdème de Reinke, des papillomes ou une leucoplasie (plaques blanches)**, ou une lésion faisant suspecter un cancer, peuvent se développer sur les cordes vocales ou ailleurs dans le larynx. Elles peuvent provoquer un enrouement, une fatigue vocale, une sensation de gêne dans la gorge et, rarement, des difficultés respiratoires. Parmi les causes figurent une utilisation incorrecte ou excessive de la voix, le tabac, le reflux, des infections (par ex. HPV) et parfois des facteurs inconnus.

Le but de l'intervention est d'enlever la lésion en préservant autant que possible le tissu sain des cordes vocales, **d'améliorer votre voix**, d'élargir les voies respiratoires si nécessaire et d'établir un **diagnostic définitif grâce à l'examen anatomopathologique** du tissu retiré.

Cabinet médical privé Op. Dr. Murat Ayata
Karacaibrahim Mah. Dereüstü Sk., Merkez, Kırklareli, Turquie
Tél.: +90 288 502 50 20 · WhatsApp: +90 555 333 21 20
info@muratayata.com · www.muratayata.com

2 Comment se déroule l'intervention ?

L'intervention est réalisée sous anesthésie générale, au bloc opératoire, par la bouche ; aucune incision n'est faite sur le cou.

1. **Accès au larynx :** Une fois que vous êtes endormi(e), un tube métallique (laryngoscope) est introduit par la bouche jusqu'au larynx. Vos dents sont protégées par un protège-dents spécial.
2. **Examen au microscope :** Les cordes vocales sont grossies à l'aide d'un microscope opératoire ou d'un endoscope et examinées en détail. Des anomalies supplémentaires, non visibles lors de la consultation, peuvent être découvertes à ce stade.
3. **Ablation de la lésion :** La lésion est retirée à l'aide d'instruments de microchirurgie très fins ou d'un laser CO2, en préservant autant que possible la surface vibrante de la corde vocale. Si nécessaire, seul un petit fragment est prélevé pour le diagnostic (biopsie).
4. **Gestes complémentaires :** Selon la situation, de petits cotons imbibés de médicament peuvent être utilisés pour arrêter le saignement, et un médicament peut être injecté dans la corde vocale pour limiter la formation de cicatrice.
5. **Fin de l'intervention :** Le laryngoscope est retiré et la bouche et les dents sont vérifiées. Il n'y a ni points de suture ni cicatrice visible sur le cou.

Très rarement, en raison d'une ouverture de bouche limitée, de la forme des dents ou de l'anatomie de la mâchoire ou du cou, il peut être impossible d'accéder au larynx en toute sécurité. Dans ce cas, l'intervention peut être interrompue et d'autres méthodes vous seront expliquées.

ANESTHÉSIE	DURÉE APPROXIMATIVE	HOSPITALISATION / SORTIE
Anesthésie générale	Environ 20 à 60 minutes	Généralement sortie le jour même ou une nuit à l'hôpital

3 Bénéfices attendus et chances de succès

- Moins d'enrouement et une voix plus claire, qui se fatigue moins vite
- Un **diagnostic définitif** grâce à l'examen anatomopathologique du tissu retiré, afin qu'une maladie découverte à un stade précoce puisse être traitée à temps
- Une respiration plus facile si la lésion rétrécit les voies respiratoires

Pour les lésions bénignes telles que les nodules, polypes et kystes, la voix s'améliore nettement chez la plupart des patients. Toutefois, le résultat dépend du type et de la taille de la lésion, de l'état antérieur des cordes vocales, de facteurs tels que le tabac et le reflux, et du respect du **repos vocal et de la rééducation vocale** après l'intervention. Certaines affections, comme les papillomes, peuvent récidiver et nécessiter plus d'une intervention.

4 Autres options thérapeutiques

- **Rééducation vocale (avec un orthophoniste) :** Elle peut être le traitement de première intention, en particulier pour les nodules des cordes vocales, et permet souvent d'éviter l'intervention.
- **Traitement médicamenteux :** Des médicaments réduisant l'acidité gastrique ou l'inflammation peuvent être utiles lorsque le reflux ou une inflammation en est la cause.
- **Arrêt du tabac et bonne hygiène vocale :** Ils favorisent la régression de certaines lésions (par ex. œdème de Reinke).
- **Geste en cabinet sous anesthésie locale :** Pour certaines petites lésions ou biopsies soigneusement sélectionnées, un geste peut être réalisé alors que vous êtes éveillé(e), à l'aide d'un endoscope introduit par le nez ou la bouche ; cela ne convient pas à toutes les lésions.
- **Surveillance rapprochée :** Les petites lésions sans suspicion de cancer peuvent être surveillées par des examens réguliers.

Cabinet médical privé Op. Dr. Murat Ayata
Karacaibrahim Mah. Dereüstü Sk., Merkez, Kırklareli, Turquie
Tél.: +90 288 502 50 20 · WhatsApp: +90 555 333 21 20
info@muratayata.com · www.muratayata.com

5 Que se passe-t-il si l'intervention n'est pas réalisée ?

Si l'intervention n'est pas réalisée, votre enrouement peut persister ou s'aggraver. La nature exacte de la lésion n'étant pas connue, le diagnostic d'une maladie grave sous-jacente (par ex. un cancer à un stade précoce ou une lésion pouvant devenir cancéreuse) peut, bien que rarement, être retardé. Les lésions qui grossissent peuvent rarement provoquer des difficultés respiratoires.

Vous avez le droit de refuser l'intervention proposée, de la reporter ou de demander l'avis d'un autre médecin. Cette décision n'aura aucune incidence sur les autres soins qui vous sont proposés. Vous pouvez retirer votre consentement à tout moment avant le début de l'intervention ; sachez toutefois qu'une fois l'intervention commencée, il peut exister des étapes auxquelles l'interrompre serait médicalement risqué.

6 Préparation à l'intervention

- Des analyses de sang seront réalisées avant l'intervention et vous serez examiné(e) par le médecin anesthésiste.
- Vous ne devez ni manger ni boire pendant les **6 à 8 heures** précédant l'intervention (suivez les consignes du médecin anesthésiste).
- Signalez-nous impérativement toute **dent mobile, couronne, bridge, implant ou prothèse dentaire** ; les prothèses amovibles sont retirées avant l'intervention.
- Si un traitement du reflux vous a été recommandé, il pourra vous être demandé de le commencer avant l'intervention.
- Informez votre médecin de **tous les médicaments** que vous prenez (y compris les médicaments qui fluidifient le sang, l'aspirine, les antalgiques, les médicaments amaigrissants et hormonaux) ainsi que des **produits à base de plantes et compléments alimentaires** (oméga-3, vitamine E, ginkgo, ail, ginseng, huile de poisson, etc.). N'arrêtez aucun médicament de vous-même sans l'avis de votre médecin.
- Signalez-nous impérativement vos **allergies**, tout problème de saignement ou de coagulation, toute maladie cardiaque ou pulmonaire, un diabète, une hypertension artérielle ou une maladie de la thyroïde, vos opérations antérieures et tout problème rencontré lors d'une anesthésie.
- S'il existe une possibilité que vous soyez enceinte, ou si vous allaitez, dites-le-nous avant l'intervention.
- Le tabac et les produits à base de nicotine altèrent nettement la cicatrisation. Si possible, arrêtez au moins 2–4 semaines avant l'intervention et ne fumez pas pendant la convalescence.

7 Convalescence : à quoi vous attendre

Premières 24 à 48 heures	Vous pouvez avoir mal à la gorge ou ressentir une brûlure, une légère gêne en avalant, un enrouement et quelques crachats teintés de sang. Vous pouvez remarquer un engourdissement de la langue, une modification du goût ou une douleur de la mâchoire ; ces symptômes disparaissent généralement en quelques jours.
1re semaine	Votre médecin recommandera généralement **3 à 7 jours de repos vocal complet** (ne pas parler, ne pas chuchoter), suivis d'une reprise progressive de l'utilisation de la voix. La plupart des personnes peuvent reprendre un travail de bureau en 2 à 3 jours ; les professionnels de la voix (enseignants, chanteurs, personnel de centre d'appels) doivent attendre plus longtemps.
2e à 4e semaine	La voix s'améliore progressivement. Une rééducation vocale est commencée si nécessaire. Évitez de crier, de chanter et de parler longtemps. Le résultat anatomopathologique est généralement disponible pendant cette période et sera discuté avec vous.
1er au 3e mois	La cicatrisation des cordes vocales s'achève ; la voix définitive apparaît généralement en **6 à 12 semaines**. Lors de la consultation de contrôle, les cordes vocales sont examinées à l'endoscope.

Cabinet médical privé Op. Dr. Murat Ayata
Karacaibrahim Mah. Dereüstü Sk., Merkez, Kırklareli, Turquie
Tél.: +90 288 502 50 20 · WhatsApp: +90 555 333 21 20
info@muratayata.com · www.muratayata.com

8 Risques et complications possibles

Comme tout acte médical, cette intervention comporte certains risques. Ci-dessous, les **effets temporaires attendus** et les **complications** sont présentés séparément et regroupés selon leur fréquence. Les chiffres indiqués sont des valeurs **approximatives** issues de la littérature médicale ; votre risque personnel peut être plus faible ou plus élevé selon votre âge, votre état de santé général, votre tabagisme et vos opérations antérieures.

La grande majorité des complications sont **temporaires** et s'améliorent avec un traitement adapté. Des événements très rares mais graves sont également mentionnés ; leur présence dans cette liste ne signifie pas qu'ils vous arriveront, mais vous devez les connaître pour prendre une décision éclairée.

Effets temporaires attendus (ce ne sont pas des complications — ils font normalement partie de la guérison)

- Mal de gorge et légère gêne en avalant (quelques jours)
- Enrouement temporaire ou modification de la hauteur de la voix après l'intervention
- Quelques crachats teintés de sang (1er et 2e jour)
- Sensibilité de la mâchoire, des lèvres ou des dents ; petites gerçures aux commissures des lèvres

Situations fréquentes (la plupart sont temporaires ou disparaissent avec un traitement)

- **Engourdissement de la langue et modification du goût** — Dus à la pression du laryngoscope sur la langue ; surviennent chez environ **5 à 15 patients sur 100** et disparaissent généralement en quelques jours à quelques semaines, persistant très rarement plusieurs mois.
- **Douleur de l'articulation de la mâchoire** — Due au maintien prolongé de la bouche ouverte ; disparaît généralement en quelques jours. Elle peut être plus fréquente et durer plus longtemps chez les personnes ayant déjà des problèmes de l'articulation de la mâchoire.
- **Voix moins améliorée que prévu** — La voix ne redevient pas toujours complètement normale après l'intervention ; une rééducation vocale ou un traitement complémentaire peut être nécessaire.

Situations peu fréquentes

- **Lésion dentaire** — Malgré l'utilisation d'un protège-dents, environ **1 à 5 patients sur 100** peuvent avoir une dent ébréchée, fêlée ou déchaussée, ou une couronne/un bridge endommagé(e). Le risque est plus élevé en cas de dents mobiles, cariées ou artificielles ; des soins dentaires peuvent être nécessaires.
- **Aggravation de la voix ou modification permanente de la voix** — Si du tissu cicatriciel se forme à la surface de la corde vocale, la voix peut devenir plus enrouée, plus faible ou se fatiguer plus vite qu'avant l'intervention. Cela peut nécessiter une rééducation vocale et parfois d'autres interventions ; rarement, cette modification peut être permanente.
- **Récidive de la lésion** — La lésion peut réapparaître, en particulier si le mauvais usage de la voix ou le tabagisme se poursuivent, ou dans des affections comme les papillomes, et une nouvelle intervention peut être nécessaire.
- **Formation d'une palmure à l'avant des cordes vocales** — Lorsque les deux cordes vocales sont traitées près de leur partie avant, elles peuvent se coller l'une à l'autre ; cela peut altérer la qualité de la voix et une seconde intervention peut être nécessaire pour les séparer.
- **Traitement complémentaire selon le résultat anatomopathologique** — Le résultat anatomopathologique peut être différent de ce qui était attendu (par ex. une lésion susceptible de devenir cancéreuse, ou un cancer). Dans ce cas, une intervention complémentaire, une radiothérapie ou une surveillance rapprochée peuvent être nécessaires ; cela vous sera expliqué en détail.

Cabinet médical privé Op. Dr. Murat Ayata
Karacaibrahim Mah. Dereüstü Sk., Merkez, Kırklareli, Turquie
Tél.: +90 288 502 50 20 · WhatsApp: +90 555 333 21 20
info@muratayata.com · www.muratayata.com

Situations rares ou très rares, mais potentiellement graves

- **Gonflement (œdème) du larynx et difficultés respiratoires** — Un gonflement du larynx peut survenir après l'intervention. Il s'améliore généralement grâce aux médicaments ; très rarement, une surveillance en réanimation ou une ouverture temporaire dans le cou pour sécuriser les voies respiratoires (trachéotomie) peut être nécessaire.
- **Saignement** — Un saignement important est rare. En raison du risque de passage de sang dans les voies respiratoires, un saignement grave peut nécessiter une intervention urgente et un retour au bloc opératoire.
- **Risques liés au laser** — Lorsqu'un laser CO2 est utilisé, il existe un risque de brûlure des tissus voisins et, très rarement, d'inflammation de la sonde d'intubation (feu dans les voies respiratoires). Des mesures de sécurité spécifiques au laser (sonde spéciale, cotons humides, protection des yeux) sont appliquées. Si cela se produisait, cela pourrait provoquer de graves brûlures des voies respiratoires et nécessiter un traitement prolongé en réanimation ainsi qu'une trachéotomie.
- **Blessure de la bouche, de la langue, des lèvres ou de la gorge** — Les petites blessures dues aux instruments cicatrisent généralement d'elles-mêmes ; très rarement, des points de suture peuvent être nécessaires. Exceptionnellement, une déchirure de la paroi de la gorge peut laisser de l'air s'échapper sous la peau du cou (sensation de crépitement) ou provoquer une infection du cou ; cela peut nécessiter une surveillance à l'hôpital, des antibiotiques par voie intraveineuse et, rarement, une intervention chirurgicale.
- **Problèmes cervicaux** — La tête étant inclinée vers l'arrière, des douleurs du cou peuvent survenir — en particulier chez les personnes atteintes d'une maladie de la colonne cervicale — et, très rarement, des problèmes vertébraux plus graves. Veuillez nous signaler tout antécédent de hernie discale cervicale ou de chirurgie du cou.

Risques généraux propres à toute intervention chirurgicale / médicale

- **Risques liés à l'anesthésie :** Si une anesthésie générale ou une sédation est utilisée, ses risques (nausées, maux de gorge, lésion dentaire, réaction allergique et, très rarement, problèmes cardiaques ou pulmonaires) vous seront expliqués séparément par le médecin anesthésiste, et votre consentement sera recueilli sur un **formulaire de consentement à l'anesthésie distinct**.
- **Saignement et transfusion sanguine :** Le recours à une transfusion sanguine est très rare dans ces interventions. En cas de saignement important, du sang ou des produits sanguins peuvent être nécessaires ; ils comportent leurs propres risques, très rares (allergie ou infection, par exemple).
- **Infection :** Une infection de la plaie après l'opération est généralement traitée par antibiotiques ; rarement, un drainage (évacuation du pus) peut être nécessaire.
- **Caillots de sang dans les veines des jambes (thrombose veineuse profonde, TVP) et dans les poumons (embolie pulmonaire) :** Très rares lors des interventions courtes de la tête et du cou. Se lever et marcher tôt réduit le risque. Les traitements hormonaux, le tabac, l'obésité et des antécédents de caillots augmentent le risque.
- **Allergie médicamenteuse :** Une réaction allergique peut survenir aux médicaments, antiseptiques, sparadraps ou fils de suture utilisés.
- **Cicatrices et troubles de la cicatrisation :** L'aspect des cicatrices varie d'une personne à l'autre ; très rarement, une cicatrice épaisse (hypertrophique) ou une chéloïde peut se former.
- **Risque vital :** Le décès lors d'une chirurgie programmée de la tête et du cou est aujourd'hui extrêmement rare ; cependant, aucune intervention chirurgicale n'est totalement dénuée de risque. Une complication grave peut nécessiter une prise en charge en réanimation et entraîner un handicap permanent.

Cette liste ne comprend pas toutes les complications possibles ; d'autres événements imprévisibles et très rares peuvent survenir. Si une complication apparaît, votre médecin planifiera le traitement et le suivi nécessaires ; cela peut nécessiter un traitement supplémentaire, des médicaments, des actes complémentaires ou une nouvelle opération.

Cabinet médical privé Op. Dr. Murat Ayata
Karacaibrahim Mah. Dereüstü Sk., Merkez, Kırklareli, Turquie
Tél.: +90 288 502 50 20 · WhatsApp: +90 555 333 21 20
info@muratayata.com · www.muratayata.com

9 Quand nous contacter immédiatement

- **Essoufflement**, ou bruit sifflant ou rauque à l'inspiration (stridor)
- **Toux ou vomissements de sang**, ou crachats teintés de sang qui augmentent au lieu de diminuer
- **Impossibilité d'avaler**, ou douleur ou gonflement si importants que vous ne pouvez pas avaler votre salive
- **Fièvre supérieure à 38,5 °C** avec un mal de gorge qui ne cesse de s'aggraver
- Gonflement du cou ou du visage, ou sensation de crépitement sous la peau

Si l'un de ces signes apparaît, appelez votre médecin sans attendre : +90 288 502 50 20 · WhatsApp +90 555 333 21 20. Si vous ne parvenez pas à nous joindre, rendez-vous au service d'urgences le plus proche ou appelez le 112 (numéro d'urgence en Turquie et dans toute l'Europe).

10 Conseils concernant les médicaments et la vie quotidienne

- Respectez strictement le **repos vocal** recommandé ; chuchoter fatigue aussi les cordes vocales. Vous pouvez communiquer par écrit ou à l'aide d'applications sur votre téléphone.
- Buvez beaucoup d'eau et maintenez l'air de votre pièce humide. Évitez autant que possible de vous racler la gorge et de tousser.
- Tenez-vous à l'écart du tabac et de la fumée de cigarette ; le tabac nuit à la cicatrisation et augmente le risque de récidive de la lésion.
- Si un médicament contre le reflux vous a été prescrit, prenez-le pendant la durée recommandée ; ne mangez pas dans les 2 à 3 heures précédant le coucher et limitez les aliments épicés et acides.
- Les voyages en avion sont généralement sans danger dès le lendemain ; poursuivez le repos vocal pendant le trajet.
- Prenez les médicaments qui vous ont été prescrits (antibiotiques, antalgiques, etc.) à la dose et pendant la durée recommandées. Ne prenez pas d'aspirine ni de médicaments similaires susceptibles d'augmenter le saignement sans avoir consulté votre médecin.
- Lors d'un vol ou d'un trajet de plus de 4 heures après l'opération, buvez beaucoup d'eau, bougez régulièrement et portez des bas de contention si cela vous a été conseillé ; cela réduit le risque de caillots dans les jambes.
- Pendant la convalescence, il est conseillé de ne pas boire d'alcool et d'éviter le tabac et les produits à base de nicotine.
- Veuillez vous présenter à tous les rendez-vous de suivi. Si vous êtes venu(e) de l'étranger, le suivi après votre retour peut se poursuivre par consultation en ligne et photos/vidéos ; si vous devez consulter un médecin sur place, un compte rendu opératoire écrit et nos recommandations vous seront remis.

11 Situations imprévues pendant l'intervention, prélèvements de tissus et produits sanguins

Si une situation imprévue survient pendant l'intervention, votre médecin restera dans le cadre de l'intervention à laquelle vous avez consenti dans ce formulaire. **Sauf en cas de danger vital ou de risque d'atteinte grave d'un organe**, aucun acte supplémentaire auquel vous n'avez pas consenti ne sera réalisé ; dans ce cas, l'intervention sera terminée à un stade sûr et vous serez informé(e) ensuite afin que la décision soit prise avec vous. Si votre vie est en danger, les soins d'urgence nécessaires pour protéger votre vie ou l'organe seront réalisés.

Les tissus retirés pendant l'intervention seront, si nécessaire, envoyés pour **examen anatomopathologique** afin de confirmer le diagnostic. Selon le résultat, un traitement ou un suivi complémentaire peut être nécessaire.

Une transfusion sanguine est très rarement nécessaire dans ces interventions et ne sera réalisée qu'en cas de nécessité vitale. Si vous n'acceptez pas le sang ou les produits sanguins (par exemple pour des raisons religieuses), vous devez nous le signaler avant l'intervention ; les conséquences possibles de cette décision seront discutées séparément avec vous et consignées dans la rubrique « Informations vous concernant personnellement ».

Cabinet médical privé Op. Dr. Murat Ayata
Karacaibrahim Mah. Dereüstü Sk., Merkez, Kırklareli, Turquie
Tél.: +90 288 502 50 20 · WhatsApp: +90 555 333 21 20
info@muratayata.com · www.muratayata.com

12 Photographies, enregistrements d'images et vos données personnelles

Des **photographies/vidéos** peuvent être réalisées avant et après l'intervention pour la planification, le suivi et l'évaluation du résultat. Ces enregistrements font partie de votre dossier médical et restent confidentiels. Vos images ne seront **jamais utilisées à des fins publicitaires, promotionnelles ou sur les réseaux sociaux.**

Vos images ne peuvent être utilisées à d'autres fins **qu'avec votre autorisation distincte et explicite**. Un refus n'aura aucune incidence sur votre traitement, et vous pouvez retirer votre autorisation à tout moment :

- ☐ J'accepte que mes images soient utilisées **uniquement pour le dossier médical et le suivi du traitement**.
- ☐ J'autorise l'utilisation de mes images pour des publications scientifiques et l'enseignement médical **d'une manière qui ne permet pas de m'identifier** (visage/zone des yeux masqués).
- ☐ J'autorise l'utilisation de mes images pour des publications scientifiques et l'enseignement médical **d'une manière qui peut permettre de m'identifier**.
- ☐ Je **n'autorise pas** l'utilisation à des fins scientifiques/pédagogiques.

Vos données personnelles et de santé sont traitées conformément à la loi turque n° 6698 relative à la protection des données personnelles (KVKK) et à la législation sanitaire applicable, à des fins de diagnostic, de traitement et d'obligations légales, par des personnes soumises au secret professionnel. Pour plus de détails, vous pouvez consulter notre notice d'information sur la protection des données.

13 Informations et remarques vous concernant personnellement (à remplir par le médecin)

Risques supplémentaires propres au patient (maladies associées, médicaments, opérations antérieures), détails du plan, attentes du patient, questions posées et réponses apportées. S'il n'y a rien à ajouter, inscrire « néant ».

14 Déclaration du patient

- ☐ J'ai lu et compris ce formulaire dans ma langue. On m'a laissé suffisamment de temps de réflexion ; j'ai eu la possibilité de poser des questions et j'ai reçu des réponses satisfaisantes.
- ☐ Mon état de santé, le but de l'intervention proposée, la manière dont elle sera réalisée, par qui et où, sa durée approximative, les bénéfices attendus, les chances de succès, les alternatives et ce qui peut se passer si elle n'est pas réalisée m'ont été expliqués oralement et par écrit.
- ☐ Les risques fréquents et potentiellement graves, ainsi que les conséquences possibles de ces complications (y compris la nécessité éventuelle d'un traitement complémentaire ou d'une nouvelle intervention/opération), m'ont été expliqués. Je comprends que le résultat d'aucun acte médical **ne peut être garanti à 100 %**.
- ☐ J'ai fourni des informations exactes et complètes sur mon état de santé, les médicaments que je prends, mes allergies et mes maladies antérieures. Je comprends que des informations incomplètes ou inexactes peuvent augmenter les risques.
- ☐ Je comprends que le respect des consignes données avant et après l'intervention contribue au résultat et qu'il est important de me présenter aux rendez-vous de suivi.
- ☐ Je sais que je peux retirer mon consentement à tout moment avant le début de l'intervention. Je comprends que la signature de ce formulaire ne décharge pas le médecin de son devoir de prudence et de diligence.
- ☐ Je prends cette décision de mon plein gré, sans aucune pression de quiconque.

Cabinet médical privé Op. Dr. Murat Ayata
Karacaibrahim Mah. Dereüstü Sk., Merkez, Kırklareli, Turquie
Tél.: +90 288 502 50 20 · WhatsApp: +90 555 333 21 20
info@muratayata.com · www.muratayata.com

- ☐ Je comprends que, s'il s'avère pendant l'intervention que le larynx ne peut pas être atteint en toute sécurité, l'intervention peut être interrompue, et qu'un traitement complémentaire ou une surveillance pourront être nécessaires en fonction du résultat anatomopathologique du tissu retiré.
- ☐ Je comprends que la voix définitive dépend aussi du respect, de ma part, du repos vocal, de la rééducation vocale, de l'arrêt du tabac et du traitement du reflux après l'intervention.

- ☐ **Je DONNE MON CONSENTEMENT à l'intervention décrite ci-dessus.**
- ☐ **Je N'ACCEPTE PAS l'intervention décrite ci-dessus. Les conséquences possibles d'un refus m'ont été expliquées.**

Nous recommandons au patient d'écrire de sa propre main : « J'ai lu et compris ce formulaire et je donne mon consentement. »

15 Signatures

	NOM ET PRÉNOM	SIGNATURE	DATE / HEURE
Patient			
Représentant légal (parent / tuteur) — lien de parenté :			
Médecin délivrant l'information et réalisant l'intervention			
Interprète (si nécessaire) — langue :			
Témoin (si nécessaire)			

Déclaration de l'interprète : J'ai traduit intégralement et fidèlement ce formulaire ainsi que les explications orales du médecin au patient / représentant légal, dans une langue qu'il comprend.

POUR LES PATIENTS DE MOINS DE 18 ANS OU DONT LA CAPACITÉ DE DÉCISION EST LIMITÉE

Pour les patients de moins de 18 ans, le consentement est donné par un **parent ou le tuteur légal**. L'enfant est informé de manière adaptée à son âge et à sa maturité, et son avis est recherché. Pour les patients dont la capacité juridique est limitée, le consentement est donné par le représentant légal.

- ☐ Si nous exerçons conjointement l'autorité parentale, je déclare que l'autre parent est informé de cette intervention et y consent.
- ☐ Je déclare qu'il n'existe aucune décision de justice ni aucun litige concernant l'autorité parentale / la tutelle (le cas échéant, le document correspondant a été présenté au médecin).

L'enfant a été informé de manière adaptée à son âge ; avis de l'enfant : _____

Ce formulaire est établi en deux exemplaires : l'un est conservé dans le dossier du patient, l'autre est remis au patient / représentant légal.

Op. Dr. Murat Ayata
Kulak Burun Boğaz
Spécialiste en oto-rhino-laryngologie et chirurgie cervico-faciale

Cabinet médical privé Op. Dr. Murat Ayata
Karacaibrahim Mah. Dereüstü Sk., Merkez, Kırklareli, Turquie
Tél.: +90 288 502 50 20 · WhatsApp: +90 555 333 21 20
info@muratayata.com · www.muratayata.com

RETRAIT DU CONSENTEMENT (À REMPLIR UNIQUEMENT SI VOUS CHANGEZ D'AVIS)

Je retire le consentement que j'ai donné ci-dessus. Les conséquences possibles de ce retrait m'ont été expliquées.

Nom, signature, date et heure du patient / représentant qui retire son consentement : _____

Ce formulaire a été établi conformément au Règlement turc sur les droits des patients et aux principes de l'Association médicale turque en matière de consentement éclairé. Il complète, sans la remplacer, l'information orale donnée par votre médecin.